

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

ozanimod 0.23mg, 0.46mg, 0.92mg

(제포시아캡슐(ozanimod 0.92mg), 제포시아캡슐스타터팩(ozanimod 0.23mg, 0.46mg), (유)한국비엠에스제약)

☐ 제형, 성분·함량:

- 0.23 mg: 흰색 내지 연한 노란색의 가루가 든 상하부 회색의 불투명한 캡슐
- 0.46 mg: 흰색 내지 연한 노란색의 가루가 든 상부 회색, 하부 오렌지색의 불투명한 캡슐
- 0.92mg: 흰색 내지 연한 노란색의 가루가 든 상하부 오렌지색의 불투명한 캡슐

☐ 효능·효과

- 보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등의 치료) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등증에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제8차 약제급여평가위원회: 2023년 8월 3일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 6월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등의 치료) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등증에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료”에 허가받은 약제로 대체약제와 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 투약비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■ 원/0.92mg/캡슐, ■■■■ 원/스타터팩) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가 환산금액의 ■■■■%, ■■■■ 원/0.92mg/캡슐, ■■■■ 원/스타터팩) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등의 치료) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등증에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 TNF- α 저해제, JAK 저해제 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료”에 허가받은 경구용 캡슐제로 sphingosine-1-phosphate (S1P) 수용체를 조절하는 새로운 기전의 약제임.
- 교과서¹⁾²⁾에서 궤양성대장염의 치료에 최근 FDA에서 허가 받은 약제로서 신청품의 기전 및 용법 용량 등이 언급됨.
- 임상지침³⁾에서 중등도 및 중증 궤양성 대장염 환자의 유도요법 및 유지요법에서 신청

품을 권고하고 있음.

- **[TRUE NORTH]⁴⁾** 18~75세의 최소 3개월 이전에 진단된 중등도~중증 활성 궤양성 대장염 환자⁵⁾로서 내시경 검사 최소 2~3주 전 경구 aminosalicylates 또는 prednisolone 복용을 시작하여 신청품의 도입기간까지 유지용량으로 복용한 환자(n=1,012)를 코호트 1(n=645), 코호트2(n=307)로 나누어 다국적, 다기관, 이중맹검, 무작위배정 3상 임상을 실시하였음.

- 유도기간(10주)동안 코호트1의 환자는 2:1로 신청품과 위약으로 배정하여 투여하였으며, 코호트2 환자는 open-label로 신청품을 동일 용량으로 투여함. 유도기간(52주) 동안 유도기간에서 신청품 투여 후 임상적 반응이 있었던 환자를 대상으로 신청품과 위약을 1:1로 이중맹검 무작위 배정하여 투여함. 유도기간동안 임상적 반응이 없는 환자들은 10주차 이후 open-label extension trial에 들어갔으며, 유지기간에 포함된 환자들은 52주차 또는 재발이후 extension trial에 들어갔음.
- 1차 평가 지표인 임상적 관해⁶⁾를 달성한 환자의 비율은 투여기간 10주시점(유도기간)에서 신청품 18.4%, 위약군에서 6.0%, 투여기간 52주시점(유지기간)에서 신청품군이 37.0%, 위약군 18.5%로 두 기간 모두 신청품군이 위약군 대비 유의한 차이를 보였음($p < 0.001$)
- 2차 평가 지표인 임상적 반응⁷⁾을 보인 환자 비율, 내시경적 개선⁸⁾, 점막 치유⁹⁾, 임상적 관해 유지¹⁰⁾, glucocorticoid-free 관해¹¹⁾ 등의 지표에서 모두 신청품군이 위약군 대비 유의한 개선을 보였음.
- 안전성 평가 결과, 자주 발생하는 이상반응은 빈혈, 비인두염, 두통, 알라닌 아미노전이효소 증가, 관절통, γ -글루타밀전이효소 증가 등이었으며, 심각한 이상반응은 유도기간에서 신청품군이 위약군 대비 발생률이 높았으나, 유지기간에서는 신청품군의 발생률이 위약군에 비해 발생률이 낮았음.

- **[네트워크 메타분석]¹²⁾** 18세 이상 이전에 생물학적 제제 투여 경험이 없거나 적어도 하나의 생물학적 제제에 투여 경험이 있는 중등도~중증 궤양성 대장염 환자¹³⁾를 대상으로 한 위약 또는 활성대조군을 포함하며, 임상적 관해 및 내시경적 개선을 평가한 3상 무작위 배정 임상시험을 선정하여 궤양성 대장염 치료제 간의 유도요법, 유지요법 시 안전성, 유효성 등을 평가하였음.

- 1차 평가변수인 임상적 관해¹⁴⁾는 신청품은 유도요법, 유지요법 모두 upadacitinib, filgotinib 100mg을 제외한 다른 모든 약제와 유의한 차이를 보이지 않았으며, 유도요법에서 filgotinib 100mg 대비 유의한 개선을 보였음.
- 2차 평가변수인 내시경적 개선¹⁵⁾ 지표는 신청품은 유도요법, 유지요법 모두 upadacitinib, adalimumab을 제외한 다른 모든 약제와 유의한 차이를 보이지 않았으며, 유도요법에서 adalimumab 대비 유의한 개선을 보였음.
- 안전성 평가 결과, 부작용 및 심각한 부작용은 치료군 간의 유의한 차이가 없었음.

- 관련 학회의견¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾에 따르면, 신청품은 궤양성 대장염에 사용가능한 새로운 기전의 치료제로 평생 치료가 필요한 질환의 특성상 치료 약제의 선택의 폭을 넓히는 옵션이 될 수 있으며, 투약이 편리한 경구 치료제로 모든 차수에서 사용 가능하여 환자 순응도를 높일 수 있는 약제로 언급함.

○ 비용 효과성

- 대체약제 선정: adalimumab, infliximab, golimumab, ustekinumab, vedolizumab, tofacitinib
- 소요비용 비교
 - 신청품의 1일 소요비용은 ■■■■■ 원, 대체약제 1일 소요비용은 ■■■■■ 원임.
 - 신청약가, 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 및 약가협상생략기준금액은 다음과 같음.

(단위: 원)

구분	신청약가	대체약제 가중평균가로 환산된 금액	약가협상 생략기준금액
캡슐	■■■■■	■■■■■	■■■■■
스타터팩	■■■■■	■■■■■	■■■■■

○ 재정 영향²⁰⁾

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상 사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 1차년도 약 ■■■■ 억원, 3차년도에 약 ■■■■ 억원이 되고, 대체약제의 대체로²³⁾ 1차년도에 약 ■■■■ 억원, 3차년도에 약 ■■■■ 억원이 증가할 것으로 예상됨.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■ 억원, 3차년도에 약 ■■■■ 억원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가중 5개국(미국, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Greenberger's CURRENT Diagnosis & Treatment Gastroenterology, Hepatology, & Endoscopy, 4e, Chapter 2: Inflammatory Bowel Disease: Immunologic Considerations & Therapeutic Implications(2022)
- 2) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e, Chapter 55: Pharmacotherapy of Inflammatory Bowel Disease(2023)
- 3) Saudi Arabia consensus guidance for the diagnosis and management of adults with inflammatory bowel disease, Saudi Journal of Gastroenterology(2022)
- 4) Sandborn WJ et al. Ozanimod as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2021;385:1280-91
- 5) Total Mayo score 6-12점; 내시경 하위점수 2점 이상, 직장 출혈 하위점수 1점 이상, 대변 빈도 하위점수 1점 이상
- 6) Mayo score에서 직장출혈(rectal-bleeding) 점수가 0점, 배변빈도(stool-frequency) 점수 ≤ 1 이고 baseline보다 최소 1점 감소, 내시경(endoscopy) ≤ 1 인 상태
- 7) Mayo score 총점 3점 이상 감소, baseline으로부터 감소율 $\geq 30\%$ 또는 Mayo 주요 3항목 2점 이상 감소, baseline으로부터 감소율 $\geq 35\%$, rectal-bleeding ≤ 1 점인 상태 또는 rectal bleeding ≤ 1 점인 상태
- 8) mucosal endoscopy subscore ≤ 1
- 9) mucosal endoscopy subscore ≤ 1 , Geboes score < 2.0
- 10) 10주에서 임상적 관해가 52주차 유지 여부
- 11) 글루코코르티코이드 사용 없는 관해 기간 ≥ 12 주
- 12) Lasa et al. Efficacy and safety of biologics and small molecule drugs for patients with moderate-to-severe ulcerative colitis: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Feb;7(2): 161-170
- 13) Mayo 점수 6-12점, 내시경 하위 점수 2~3점
- 14) Mayo 점수 ≤ 2 로 정의, 개별 하위 점수 1이상 항목이 없는 경우
- 15) Mayo 내시경 하위 점수 0-1
- 16) 대한장연구학회(대장학 제2023-27호, 2023.4.11.)
- 17) 대한소화기학회(대소학 제2023-47호. 2023.4.13.)
- 18) 대한내과학회(대내학 2023-285호, 2023.4.24.)
- 19) 대한대장항문학회(대장학 제2023-050, 2023.4.21.)
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: ■■■■■캡슐, 2차년도: ■■■■■캡슐, 3차년도: ■■■■■캡슐)
- 22) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 $\times$ 신청 약가
- 23) 재정소요 증감금액 = (신청품 실제가 $\times$ 제약사 예상사용량) - (대체약제 가중평균가 $\times$ 제약사 예상사용량)